

14 内視鏡的治療 endoscopic therapy

A 止血法 control of bleeding

到達目標

- 種々の気道出血の際の対応法を概説できる

1 気管支鏡検査，肺生検後の出血

2016年の全国調査では，鉗子生検の0.45%で300 mLを超える重篤な気道出血が報告されている¹⁾。直視下生検時の出血は気管支鏡的なコントロールが困難なこともあり，致命的な気道出血をきたしうる気管支動脈瘤，血流が豊富な腎細胞癌や甲状腺癌などの気道内転移などには十分な注意が必要である。出血時には気管支鏡で出血部位を観察しつつ吸引し止血を待つ，末梢病変に対する経気管支肺生検後の出血に対しては，気管支ファイバースコープを先に進め出血がみられる気管支に楔入させて吸引を持続し，止血を待つ，いずれの場合も出血側を下にした側臥位にして健

側への血液流入を防ぐ，それでもコントロールできない場合は，健側主気管支にカフ付きチューブで気道を確保し窒息を回避する。

2 持続する気道出血

気管支鏡的な局所治療ではadrenalineなどの薬物散布，endobronchial watanabe spigot (EWS)を用いた気管支充填術，出血源に対するアルゴンプラズマ凝固法 (argon plasma coagulation : APC) (図1)などの治療方法がある。こうした処置でも止血困難な場合は気管支動脈塞栓術や外科的治療を考慮する。

文 献

- 1) Horinouchi H, et al : J Bronchology Interv Pulmonol 27 : 253, 2020

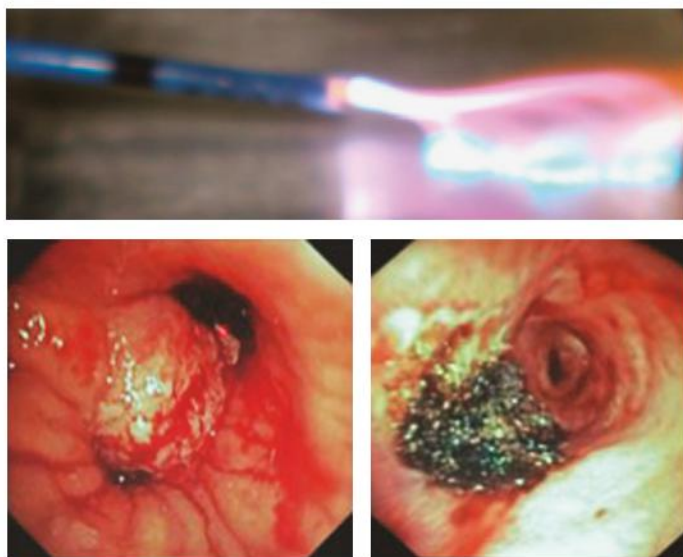


図1 アルゴンプラズマ凝固法 (APC)